PROTOCOLLO 35

Mobilizzazione bilaterale simultanea

Trattare entrambe le articolazioni nei quadri bilaterali

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Artralgia, ipomobilità	6 a 8 minuti	2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Ipomobilità bilaterale
- ✓ Rigidità simmetrica
- ✓ Artralgia bilaterale

Controindicazioni e precauzioni

- ! Trauma recente, sospetta frattura o lussazione
- ! Infezione o infiammazione articolare acuta
- ! Chirurgia dell'ATM recente senza nulla osta
- ! Ipermobilità o lussazioni ricorrenti: procedere con cautela

Posizionamento

Paziente: supino, capo in posizione neutra su un cuscino basso, muscolatura rilassata, bocca leggermente aperta.

Fisioterapista: alla testa del lettino, pollici sui molari inferiori bilateralmente, guanti monouso.

Esecuzione passo dopo passo



Presa

Pollici sui molari inferiori di entrambi i lati.



Distrazione

Trazione caudale simmetrica.



Scivolamento

Scivolamento anteriore bilaterale controllato.



Rivalutazione

Misura apertura e traiettoria.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Grado	II e III
Tempo	3 serie da 30 secondi
Pausa	30 secondi

Criteri di rivalutazione

APERTURA MASSIMA
____ mm
senza dolore e massima, con calibro

DOLORE (NRS 0 A 10)
____ / 10
a riposo e in funzione

TRAIETTORIA
Retta / Deviata
osservata allo specchio

Punti chiave

- ✓ Mantieni la simmetria della forza
- ✓ Paziente molto rilassato
- ✓ Usa guanti su entrambe le mani

Errori da evitare

- ! Asimmetria involontaria della presa
- ! Forza eccessiva
- ! Dimenticare la stabilizzazione cervicale

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Apertura simmetrica	Aprire davanti allo specchio con traiettoria retta	10 ripetizioni, 2 volte al giorno

! **Nota clinica.** Nei quadri bilaterali il trattamento simultaneo riduce i tempi e mantiene la simmetria.

Bibliografia essenziale

1. Calixtre L.B. et al. Manual therapy for the management of pain and limited range of motion in subjects with signs and symptoms of temporomandibular disorder: a systematic review of randomised controlled trials. J Oral Rehabil. 2015;42(11):847–861.
2. Armijo-Olivo S. et al. Effectiveness of manual therapy and therapeutic exercise for temporomandibular disorders: systematic review and meta-analysis. Phys Ther. 2016;96(1):9–25.